

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

FACULTE DE MEDECINE DE CONSTANTINE

ANNEE UNIVERSITAIRE 2025-2026

CHU Constantine

Service d'Hépto-Gastro-Entérologie

CAT devant une Constipation

Dr R. DJEBBAR

Maitre assistante en hépto-gastro-entérologie

Plan du cours :

- Introduction

1. Définition

2. Intérêt de la question

- II. Épidémiologie

- III. Rappel anatomophysiologique

- IV. Physiopathologie

- V. Démarche diagnostique

- VI. Examens paracliniques

- VII. Etiologies et complications

- VIII. Traitement

- IX. Conclusion

I. Introduction :

1. Définition :

La constipation est un motif fréquent de consultation en médecine générale. Il s'agit d'un symptôme difficile à évaluer. Il faudra avant tout éliminer une cause organique avant de conclure à une constipation maladie dont la cause la plus fréquente est l'insuffisance du régime alimentaire en fibres.

Sa définition pourrait être :

Clinique :

Évacuation trop rare (< 3 selles/semaine).

Ou trop difficile ou insuffisamment satisfaisante d'une selle sur digérée (**poids<35gr/j**).

Physiologique :

Est l'association d'un **ralentissement du transit (sup 72h)** colorectal, à une **déshydratation** excessive de la selle (poids sup a 22% poids total), rendant la selle dure

La persistance de symptômes au-delà de 3, voire **6 mois** permet de poser un diagnostic de constipation chronique.

On a deux types de constipation :

- la Constipation **maladie ou fonctionnelle** = Constipation primitive.
- la constipation **symptôme** = secondaire a une pathologie **organique** (digestive ou extra digestive)

2. Intérêt de la question :

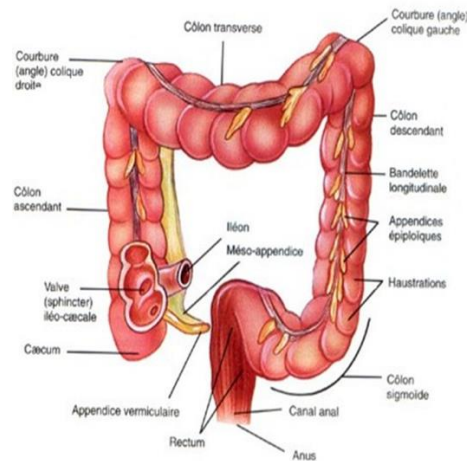
- Motif **fréquent** de consultation en gastro- entérologie et surtout en médecine générale
- Les étiologies sont dominées par **les causes fonctionnelles**.
- Ne pas passer à côté d'une pathologie organique (**+++ CCR**

II. Épidémiologie :

- Dans les pays occidentaux, la prévalence de la constipation se situe entre 15 et 20 %.
- Augmente avec l'Age et elle est deux fois plus fréquente chez la femme que chez l'homme.

- **Aucun** facteur environnemental ou sociodémographique n'a pu être identifié comme facteur de risque de constipation, seul le régime alimentaire pauvre en fibres.

III. Rappel anatomophysiologique



Ce segment digestif assure trois fonctions :

La motricité colique :

- ✓ Brassage + déshydratation du contenu endoluminal
- ✓ Stockage des fèces dans l'intervalle des exonérations
- ✓ Progression du bol fécal vers le rectum par des mouvements propulsifs 2 types de contractions :
 - Segmentaire (++CT, CD)
 - Propulsive : +rares (CS++)

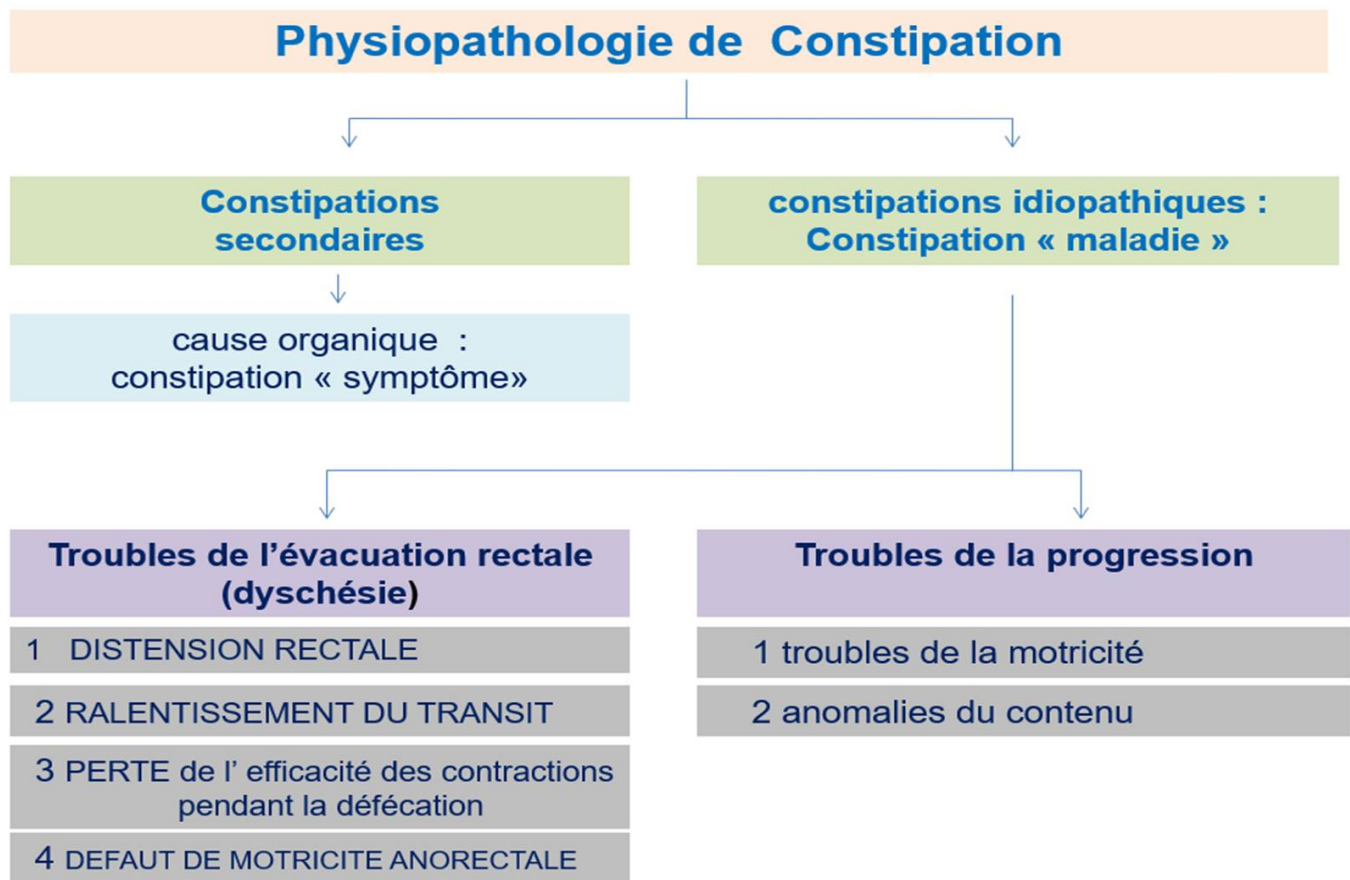
La continence anale : mécanisme permettant de retenir les selles à rectum plein assuré par trois forces

- ✓ Force propulsive : rôle du sigmoïde qui déverse son contenu dans le rectum
- ✓ Force résistive : appareil sphinctérien + plancher pelvien
- ✓ Compliance rectale : propriétés viscoélastiques

La défécation : une fois le besoin ressentie le sujet peut retenir ou exonérer.

- ✓ Contraction Muscles de la paroi abdominale : hyperpression abdominale.
- ✓ Fermeture de la charnière RS
- ✓ Alignement du Rectum dans l'axe du CA
- ✓ Contraction couche longitudinale du R
- ✓ Relâchement sphinctérien

IV. Physiopathologie



V. Démarche diagnostique

1. Interrogatoire :

a) Reconnaître la constipation :

En précisant

- Les symptômes de la constipation : **nombre** et **consistance** des selles et la **difficulté d'évacuer les selles**. (La Consistance des selles est considérée comme le meilleur indicateur du transit colique que la fréquence des selles), cette dernière est évaluée par échelle de bristol ou les patients ayant des selles Bristol **1 ou 2** ayant une augmentation significative du temps de transit.

Type 1		Boules dures séparés (scybales), difficile à expulser
Type 2		Selle moulée mais faite de grumeaux apparents
Type 3		Selle moulée mais craquelée
Type 4		Selle moulée lisse et molle
Type 5		Morceaux solides mais mous, clairement séparés les uns des autres et faciles à expulser
Type 6		Selle pâteuse avec des morceaux solides non distincts
Type 7		Selles liquides

- L'ancienneté de la constipation (passagère, durable, récente ou ancienne)
- Reconnaître les formes atypiques (constipation camouflée ou fausse diarrhée du constipé).

b) Enquête étiologique :

- Terrain :
 - ✓ Âge et Pathologies associées : neurologique ; endocrinienne ou organique
 - ✓ ATCD personnels chirurgicaux ou obstétricaux
 - ✓ ATCD familiaux de CCR ou polyposes recto-coliques
 - ✓ Prise de médicaments : opiacés, psychotropes, anticonvulsivants, anticalciques...
- Profil psychologique du patient : anxiété et état dépressif.
- Habitudes hygiéno-diététiques :
 - ✓ Absence d'activité physique
 - ✓ Alimentation **pauvre en fibres**
 - ✓ Boissons insuffisantes
- Symptômes associés : douleur, alternance diarrhée constipation.
- Signes d'alarmes :
 - ✓ Modification du calibre des selles
 - ✓ **Sang** dans les selles ou Rectorragies
 - ✓ **Anémie ferriprive**
 - ✓ **Symptômes d'obstruction**
 - ✓ **Age > 50 ans**
 - ✓ Constipation **récente**
 - ✓ Prolapsus rectal
 - ✓ **Amaigrissement, asthénie, anorexie**
 - ✓ Antécédents familiaux des CCR

2. Examen clinique : Doit être complet

A. Ex général : état général du patient, amaigrissement, pâleur, ictère, température....

B. Ex abdominal

Inspection : distension, voussure, cicatrice

Palpation : - état de la paroi abdominale

- recherche une hernie ; éventration ou masse
- apprécie la tonicité de la paroi abdominale
- examen des orifices herniaires
- sensibilité à la palpation

Percussion : tympanisme ou matité

C. Ex proctologique :

indispensable +++++ , recherche :

- matières dans l'ampoule rectale
- masse rectale
- sténose anale ou rectale
- évalue la **tonicité** du canal anal
la contraction volontaire et parfois paradoxale (anisme)
- un rectocèle chez la femme

D. Ex neurologique

E. Ex de la thyroïde

F. Ex lympho-ganglionnaire (syndrome tumoral)

VI. Examens paracliniques :

En première intention

- la coloscopie : est l'examen clé pour exclure un cancer colorectal. Elle sera demandée en cas de **signe d'alarme**.

- les examens biologiques : sont parfois justifiés en fonction des diagnostics évoqués:

- la TSH us pour chercher hypothyroïdie
- la glycémie à jeun, un hémogramme, une CRP, une créatininémie et un ionogramme peuvent faire partie des examens demandés au cas par cas.

- Le lavement baryté ou coloscanner: lorsque l'endoscopie n'est pas réalisable ou en cas de sténose infranchissable

En deuxième intention (exploration fonctionnelle+++)

Indication : Constipation ne répondant pas au traitement de première ligne après avoir éliminé une constipation secondaire

Le temps de transit colique (TTC) est l'examen de référence pour le diagnostic de constipation à transit lent.

Résultat :

- Stase dans l'ensemble du cadre colique : **C. de transit**
- Stase dans CG et LE SIGMOÏDE : **C. distale**

Manométrie anorectale avec test d'expulsion au ballonnet :

Étudie la sensibilité et la motricité de la région Ano rectale

- Absence de RRAI : +++ Hirschsprung
- Anisme : absence de relaxation de SAE lors de l'expulsion du ballonnet gonflé
- Augmentation de compliance rectale : évoquant un megarectum

Défécographie : permet l'étude de la statique et de la vidange du rectum souvent remplacé par IRM dynamique

VII. Etiologies et complications

1- Causes évidentes :

- Alitement prolongé
- Grossesse
- Post accouchée
- Malade sous neuroleptiques
- Voyages ou séjours hors du milieu habituel
- Malnutrition, cachexie

2- Causes Digestives :

a- Organiques :

- **Sténoses tumorales** : - Cancer colorectal, Cancer anal Compression : Tm ovaire, utérus, prostate Carcinose péritonéale
- **Sténoses non tumorales** : sigmoïdite diverticulaire Sténose ischémique, Sténose radique, Sténose au cours de MICI

b- Causes fonctionnelles :

la constipation fonctionnelle est définie par les critères de Rome IV

- **Troubles de l'évacuation** : Rectocèle, Prolapsus rectal, Périnée descendant, Anisme, Mégarectum.
- **Troubles de la progression** : Atonie colique/inertie colique, Dolichocôlon primitif, Insuffisance du régime alimentaire en fibres
- **Troubles de la sensibilité rectale** : (fécalome)

Tableau 1 : Critères de Rome IV pour le diagnostic de constipation fonctionnelle. Les symptômes doivent être présents durant les 3 derniers mois et être apparus au moins 6 mois auparavant (4)	
Présence de 2 ou plus des signes suivants	
Effort de poussée dans plus de 25 % des défécations	
Scybales ou selles dures (Bristol 1 ou 2) dans plus de 25 % des défécations	
Sensation d'évacuation rectale incomplète dans plus de 25 % des défécations	
Sensation d'obstruction/blocage ano-rectal dans plus de 25 % des défécations	
Manœuvres manuelles pour faciliter l'évacuation des selles (manœuvres digitales, support périnéal) dans plus de 25 % des défécations	
Moins de 3 évacuations spontanées par semaine	
Des selles liquides sont rarement présentes sans prise de laxatifs	
Absence de critères suffisant pour un diagnostic de syndrome de l'intestin irritable	

3- Causes Endocrinienne, Métaboliques et Générales :

- **Collagénoses** : sclérodermie
- **Endocriniennes** : Diabète Hypothyroïdie Hyperparathyroïdie

Métaboliques : Insuffisance rénale Hypokaliémie Hypocalcémie, hypercalcémie

4- Causes neurologiques

Système nerveux central +++: SEP, AVC, Tm, Parkinson....

5- Causes psychiatriques : Etat dépressif, Etat démentiel, Névroses

6- les complications : syndrome occlusif, fissure, fécalome, abus des laxatifs (syndrome des laxatifs)

VIII. Traitement

1. But :

- Normaliser le transit
- Traiter les causes organiques
- éviter les complications

Et donc améliorer la qualité de vie

2. Moyen :

a) Règles hygiéno-diététiques :

- Respect d'une périodicité stable de présentation à la défécation.
- Adoption d'une position dite en semi-squatting
- Une activité physique soutenue.
- Repas riche en fibre, avec une eau riche en magnésium.

b) Traitement Médical :

Type de laxatif			Mécanisme d'action	Essais randomisés ayant montré une efficacité
Laxatifs de lest	Fibres insolubles	Son de blé	Augmentation du contenu en eau dans le grêle, Accélération du transit intestinal et colique Augmentation du nombre de selles	OUI
	Fibres solubles	Psyllium, gommes, mucilages	Augmentation du contenu en eau dans le grêle et le côlon, Augmentation du poids des selles et leur fréquence	OUI
Laxatifs osmotiques	Sucrés	Lactulose, lactitol, sorbitol...	Sucres non absorbés, agissant par leur pouvoir osmotique	OUI
	Salés	Macrogols	PEG non absorbé agissant par son pouvoir osmotique	OUI
Laxatifs lubrifiants	Huile de paraffine		Agent lubrifiant	NON OUI en association avec lactulose
Laxatifs stimulants	Bisacodyl		Prodrogue métabolisée par le microbiote Stimule la motricité	OUI
	Anthraquinone, sennosides		Prodrogue métabolisée par le microbiote Stimule la motricité	NON
	Prucalopride		Agoniste 5-HT ₄ Stimule la motricité	OUI
	Pyridostigmine		Inhibiteur de l'acétylcholine estérase Stimule la motricité	NON
Autres	Linacotide		Agoniste de la guanylate cyclase Effet sécrétoire dans le côlon	OUI
Lavements			Favorise évacuation rectale	NON
Suppositoire	Glycérine		Favorise évacuation rectale	NON

c) Autres

bio-feed back

Chirurgie: Rectopexie

Myomectomie du sphincter anale interne

Sigmoïdectomie

Colectomie

Prise en charge psychologique

3. Indication : en pratique

- Laxatifs non irritants :

En première intention : laxatif osmotique, lactulose (DUPHALAC) : • 1 à 3 càs sachet /j prise

En seconde intention : laxatif lubrifiant, huile de paraffine : 1 à 3 càs /j, en général associé a un laxatif osmotique

- Laxatifs stimulants :

Ils doivent être évités sauf pour des courtes durées car ils risquent d'entraîner une colopathie aux laxatifs (diarrhée, troubles hydro électrolytiques...).

Donc

CONSTIPATION

1 ère étape : un bon interrogatoire avec un bon examen clinique



Causes organiques extra digestives éliminés



2 ème étape : rechercher les signes d 'alarmes

Oui

Coloscopie

Causes organiques digestives

Coloscopie anormale

Diagnostic établi

C. normale

Non

Constipation maladie



3 -ème étape : traitement

RHD

TRT 1 ère intention (non irritant)

Echec : 2 ème intention (non irr)

Echec : laxatifs stimulants

Echec : explorer...

Coloscopie

C. Anormale

C. Normale

Exploration fonctionnelle
(2 ème intention)



Constipation distale

Constipation de progression